Nové dáta spochybnili účinnosť: EMA odporučila zrušenie povolenia pre Tavneos (avacopan) v EÚ — čo to znamená pre ANCA-vaskulitídu aj nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Nové dáta môžu prekryť pôvodný prísľub – a rozhodnutie regulátora sa potom mení.

Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila Európskej komisii zrušiť povolenie na uvedenie na trh pre **Tavneos (avacopan)** v Európskej únii. Dôvodom nie je samotný mechanizmus účinku. Pôvodné rozhodnutie o účinnosti sa podľa EMA opieralo o údaje z kľúčovej štúdie **ADVOCATE**, v ktorej sa zistili závažné problémy s integritou dát a so súladom s princípmi **správnej klinickej praxe**. EMA preto uzavrela, že **prínosy už nie sú preukázateľne vyššie než riziká**.

Pre klinickú prax to má priamy vplyv na liečbu **granulomatózy s polyangiitídou (GPA)** a **mikroskopickej polyangiitídy (MPA)**, vrátane pacientov s postihnutím obličiek; tieto ochorenia totiž patria medzi najčastejšie príčiny rýchlo progredujúceho zlyhania obličiek.

Prečo je zrušenie povolenia závažné

Tavneos sa používa u dospelých so závažnou, aktívnou GPA alebo MPA a je súčasťou **kombinovanej liečby**, ktorá zahŕňa aj iné imunosupresíva (v praxi typicky **rituximab alebo cyklofosfamid**) a **redukciu kortikosteroidnej záťaže**.

V štúdii ADVOCATE bolo hodnotených **331 pacientov** s GPA/MPA, ktorým sa počas **52 týždňov** podával **avacopan** alebo placebo, pričom obe ramená dostávali popri štandardnej liečbe aj **kortikosteroidy počas 20 týždňov**. Na základe týchto dát sa avacopan hodnotil ako prinajmenšom porovnateľne účinný ako 20-týždňové podávanie vysokých dávok kortikosteroidov pri dosahovaní remisie, s lepšími výsledkami pri udržaní dlhodobej remisie.

EMA však po opätovnom preskúmaní dát konštatovala, že štúdia bola realizovaná **v rozpore s princípmi správnej klinickej praxe** a že údaje dodané v čase posudzovania žiadosti boli **„nesprávne a zavádzajúce“**.

Preto sa tieto výsledky už nedajú považovať za spoľahlivý dôkaz účinnosti.

Čo odporúčanie EMA znamená v praxi

Z odporúčania EMA vyplýva, že:

- **noví pacienti sa už nemajú začínať liečiť** Tavneosom,
- **pacienti, ktorí Tavneos už užívajú**, majú byť **prevedení na vhodnú alternatívnu liečbu**.

Tavneos je navyše spojený so zvýšeným rizikom **liekmi vyvolaného poškodenia pečene** a zriedkavého **syndrómu miznúcich žlčovodov** (vanishing bile duct syndrome, VBDS). EMA preto odporúča **pozorne sledovať funkciu pečene** až do trvalého ukončenia liečby. Pri podozrení na VBDS sa má liek **okamžite vysadiť**.

Odporúčanie EMA ešte nie je konečné: právne záväzné rozhodnutie pre všetky členské štáty vydá **Európska komisia**, ak odporúčanie EMA potvrdí.

Nefrologický kontext: prečo je to relevantné práve pre obličky

GPA/MPA sú systémové nekrotizujúce vaskulitídy spojené s protilátkami proti cytoplazmatickým antigénom neutrofilov (ANCA). **Renálne postihnutie** je v klinickom obraze časté a zásadné, lebo často rozhoduje o potrebe urgentnej hospitalizácie či dialýzy a o dlhodobej prognóze.

Hoci ide primárne o regulačné hodnotenie dôkazov, pre nefrológa z neho vyplývajú tri praktické otázky.

1) Prínos stratégie šetriacej kortikosteroidy je neistý

Avacopan ako antagonista receptora C5a má tlmiť zápalovú aktivitu v cievach. V praxi však veľká časť prínosu spočívala v kombinácii s režimami, ktoré umožňujú **obmedziť expozíciu kortikosteroidom**.

Ak sa účinnosť doložená štúdiou ADVOCATE už nepovažuje za spoľahlivú, treba prehodnotiť, aký kompromis medzi kontrolou vaskulitídy a minimalizáciou steroidnej toxicity je v konkrétnej situácii pre pacienta optimálny.

2) Zmena liečby musí ísť ruka v ruke s bezpečnostným sledovaním pečene

U nefrologických pacientov sa často rieši viac orgánových systémov naraz. Ak sa Tavneos ukončuje alebo nahrádza, treba zároveň:

- cielene sledovať pečeňové testy počas prechodu,
- všímať si klinické a laboratórne známky VBDS,
- koordinovať plán s multidisciplinárnym tímom (nefrológ, reumatológ/hematológ, podľa potreby hepatológ).

3) Prechod na alternatívy môže byť časovo kritický

Pri systémových vaskulitídach môže čakanie na ďalšie rozhodnutia ovplyvniť chorobnú aktivitu. Odporúčanie EMA **nezačínať liečbu u nových pacientov** a už liečených **previesť na alternatívnu liečbu** preto znamená, že lokálne protokoly by mali mať pripravený postup na rýchlu zmenu liečby.

Ako to vysvetliť pacientovi

Pacientovi je vhodné zrozumiteľne vysvetliť, že:

- EMA odporučila zrušenie povolenia,
- nejde o „bežné kolísanie účinnosti“, ale o závažné pochybnosti o dôkazoch, ktoré v minulosti podporovali registráciu,
- preto sa liečba bude nahrádzať inou štandardnou liečebnou schémou,
- počas prechodu sa bude sledovať bezpečnosť, najmä funkcia pečene.

Treba tiež povedať, že konkrétny postup závisí od aktuálnej chorobnej aktivity, stavu obličiek a komorbidít, nie od všeobecného odporúčania pre populáciu.

Záver

Odporúčanie EMA zrušiť povolenie pre **Tavneos (avacopan)** je regulačne aj klinicky významné. Dôkazy zo štúdie ADVOCATE pre problémy s integritou dát a porušenie zásad správnej klinickej praxe už nemožno považovať za spoľahlivé, a preto prínosy lieku nie sú preukázateľne vyššie než riziká.

Pre nefrológiu je to dôležité najmä u pacientov s **GPA/MPA s postihnutím obličiek**, u ktorých zmena liečebnej stratégie môže ovplyvniť kontrolu zápalu, potrebu intenzívnej starostlivosti aj bezpečnostné riziká. V praxi by sa mali okamžite riešiť dve veci: **nezačínať liečbu u nových pacientov** a **systematicky prehodnotiť liečbu aktuálne liečených**, vrátane **sledovania funkcie pečene** až do definitívneho ukončenia liečby.

Zdroj: *Rob Hicks, „New Data Lead to Decision to Revoke Autoimmune Disease Drug“, Medscape (2026). Link na zdroj.*

Poznámka: *Tento článok má vzdelávací a osvetový charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrujúceho tímu ani aktuálne stanoviská regulačných orgánov.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ema-zrusenie-povolenia-tavneos-avacopan-anca-vaskulitida · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.